

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT: 891180268-0

INFORME QUIRURGICO

Ingreso: 1955258

Página 1/2

Número de Folio: 28

Ubicación: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO E.S.E. -
RECUPERACION CIRUGIA

IDENTIFICACIÓN

Apellidos: JIMENEZ TAFUR
Nombres: LYDA PAMELA
Dirección: CALLE 11 1 G BIS 31 MARTIRES - NEIVA - NEIVA
Teléfono: 000000 - 3123659457
Profesión: PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS VARIOS
Entidad Responsable: E.P.S. SANITAS S.A.S
Seguridad Social: E.P.S. SANITAS S.A.S

Tipo Documento: CC **Numero:** 1075218751
Edad: 38 Años 01 Meses 10 Dias (11/02/1987)
Sexo: FEMENINO
Tipo Paciente: CONTRIBUTIVO
Tipo Afiliado: COTIZANTE
Estado Civil: SOLTERA
Grupo Étnico: NINGUNO DE LOS ANTERIORES

EQUIPO QUIRURGICO

Profesional	Perfil	Principal
LUIS GUILLERMO CANO ARIAS	Cirujano	☒
WILLIAM DIAZ HERRERA	Anestesiologo	☐
MARTHA CECILIA RAMOS AYA	Instrumentador	☐
SINDY MARGERY ARDILA MARTINEZ	Circulante	☐
CLERY FERNANDA CISNEROS PEREZ	RESIDENTE II AÑO	☐
MELYSSA DIAZ BOHORQUEZ	INTERNA	☐

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Diagnósticos PRE-Operatorios:

CIE10	Diagnostico	Observaciones	Principal
D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO		☒
R520	DOLOR AGUDO		☐

Diagnósticos POS-Operatorios:

D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	☒
R520	DOLOR AGUDO	☐

INTERVENCION PRACTICADA/TIPO DE ANESTESIA Y DE HERIDA

Fecha Hora de Inicio: 21/03/2025 4:25:00 p. m. **Fecha Hora que Termina:** 21/03/2025 5:49:00 p. m. **Cirugia urgente:** ☐
Tiempo Quirúrgico(Minutos): 84 **No Sala de Cirugía:** 8 **Profilaxis con**
Tipo de Herida : Limpia **Tipo de Anestesia :** Combinada **Antimicrobianos:** ☒
Clasificación ASA: 3
Datos Adicionales: Prótesis / Implante ☐ CX Caderas ☐ CX Rodillas ☐ Laparotomia ☐ Fractura Abierta ☐ **Clas. Fractura:**

Cirugías: (Can: Cantidad, P: Cirugía Principal)

Cod. C.U.P.S	Cirugía	Via Abordaje	Can. P.
652301	RESECCION DE TUMOR DE OVARIO POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☒
669101	SALPINGO-OOFORECTOMIA UNILATERAL POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☐
544104	OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
1682401	MIOMECTOMIA UTERINA (UNICA O MULTIPLE) POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☐
541703	LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐

DESCRIPCION QUIRURGICA

Hallazgo Operatorio:

UTERO AUMENTADO DE TAMAÑO 1.5 VECES DEFORMADO POR MULTIPLES MASAS SUBSEROSAS E INTRAMURALES EN CARA ANTERIOR FONDO Y CARA POSTERIOR DEL UTERO EL MAYOR DE 4CM. ANEXO IZQUIERDO NORMAL. ANEXO DERECHO CON MASA TUMORAL DE CONSISTENCIA CAUCHOSA, BORDES REGULARES DE 14X12CM, NO ADHERIDA. FONDO DE SACO LIBRE. PARAMETRIOS LIBRES. VEJIGA, RECTO Y URETERES INDEMNES. APÉNDICE NORMAL. EPIPLON NORMAL. HIGADO, BAZO, ESTÓMAGO, VESICULA BILIAR Y ASAS INTESTINALES DELGADAS Y GRUESAS NORMALES. GOTERAS PARIETOCÓLICAS Y CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS LIBRE.

PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES. SANGRADO 100CC. ORINA CLARA AL FINALIZAR. CONTEO Y RECONTEO DE

COMPRESA E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

DX BIOPSIA POR CONGELACIÓN: TUMOR DE OVARIO DERECHO: DRA RINA LUNA PATOLOGA:
CISTOADENOMA SEROSO DE OVARIO. DX DEFINITIVO EN MÚLTIPLES CORTES EN PARAFINA.

Detalle Quirúrgico - Procedimientos:

BAJO ANESTESIA COMBINADA PREVIA ASEPSIA DEL CAMPO OPERATORIO Y CATETERISMO VESICAL, SE REALIZA INCISIÓN MEDIANA INFRA Y SUPRAUMBILICAL. SE INCIDE POR PLANOS HASTA CAVIDAD. SE IDENTIFICAN ESTRUCTURAS PÉLVICAS Y ABDOMINALES CON LOS HALLAZGOS DESCRITOS. SE REALIZA LAVADO PELVICO. SE ABRE HOJA POSTERIOR DEL PERITONEO Y SE IDENTIFICAN VASOS PÉLVICOS Y URETER DERECHO. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN CON LIGASURE LIGAMENTO INFUNDIBULOPELVICO DERECHO Y CUENO DERECHO Y SE ENVIA TUMOR DE OVARIO A PATOLOGIA. SE REALIZA OMENTECTOMIA PARCIAL CON LIGASURE. SIN COMPLICACIONES. SE REALIZA MIOMECTOMIA UTERINA MÚLTIPLE (4) CON MONOPOLAR Y DISECCIÓN ROMA Y SE SUTURA CON CCD2-0 EN DOS PLANOS. SE REVIS A HEMOSTASIA. SE RETIRAN COMPRESAS Y SE REVIS A EXHAUSTIVAMENTE LA CAVIDAD DESCARTANDO LA PRESENCIA DE CUERPO EXTRAÑO Y SE ORDENA A LA INSTRUMENTADORA RESPONSABLE EL CONTEO Y RECONTEO DE COMPRESAS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EL CUAL ES INFORMADO COMO COMPLETO POR LO QUE SE CIERRA POR PLANOS HASTA PIEL. NO COMPLICACIONES.

Complicaciones:

NINGUNA

Materiales (Que se Deben Cobrar Adicional a la Tarifa de los Qx):

LIGASURE

Compresas: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Gasas: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Conteo Material: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Tejidos Enviados a Anatomía Patológica:

Número de Muestras: 4

ANEXO DERECHO TUMORAL (OVARIO Y TROMPA UTERINA). EPIPLON. MIOMAS UTERINOS. LAVADO PELVICO.

RECOMENDACIONES

NADA VIA ORAL
LACTATO RINGER 100CC/HORA
DIETA LÍQUIDA AL DESAYUNO Y BLANDA AL ALMUERZO.
ANALGESIA POR ANESTESIA
OMEPRAZOL 60MG IV/DIA
METOCLOPRAMIDA 10MG IV CADA 8 HORAS
ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEO/DIA INICIAR EN 12 HORAS
TERAPIA RESPIRATORIA CON INCENTIVO RESPIRATORIO 2 VECES/DIA
SONDA VESICAL A CISTOFLO
CSV Y T CADA 4 HORAS
AVISAR CAMBIOS.



Profesional: LUIS GUILLERMO CANO ARIAS

Especialidad: GINECOLOGIA ONCOLOGICA

Tarjeta Profesional # 12126929

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT: 891180268-0

INFORME QUIRURGICO

Ingreso: 1953784

Página 1/3

Número de Folio: 54

Ubicación: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO E.S.E. -
RECUPERACION CIRUGIA

IDENTIFICACIÓN

Apellidos: FLORIANO CASTRO

Nombres: ERIKA YOANNA

Dirección: VEREDA SAN ISIDRO - SUAZA - SUAZA

Teléfono: 3208874779 - 3107690994

Profesión: NO SE TIENE ESTA INFORMACION

Entidad Responsable: NUEVA EPS

Seguridad Social: NUEVA EPS

Tipo Documento: CC Numero: 55117932

Edad: 44 Años 10 Meses 26 Dias (25/04/1980)

Sexo: FEMENINO

Tipo Paciente: SUBSIDIADO

Tipo Afiliado: NO APLICA

Estado Civil: CASADA

Grupo Étnico: NINGUNO DE LOS ANTERIORES

EQUIPO QUIRURGICO

Profesional	Perfil	Principal
LUIS GUILLERMO CANO ARIAS	Cirujano	☒
WILLIAM DIAZ HERRERA	Anestesiologo	☐
LINDA CATALINA MARTINEZ VALLEJO	Instrumentador	☐
SINDY MARGERY ARDILA MARTINEZ	Circulante	☐
KERLY JOHANNA YAÑEZ CAICEDO	Circulante	☐
CLERY FERNANDA CISNEROS PEREZ	r go	☐
OSNAIDER ANDRES CUELLO TORRES	r anestesia	☐

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Diagnósticos PRE-Operatorios:

CIE10	Diagnostico	Observaciones	Principal
C56X	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	IZQUIERDO ORADS IV	☒
R520	DOLOR AGUDO		☐

Diagnósticos POS-Operatorios:

C56X	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	IZQUIERDO ORADS IV	☒
R520	DOLOR AGUDO		☐

INTERVENCION PRACTICADA/TIPO DE ANESTESIA Y DE HERIDA

Fecha Hora de Inicio: 21/03/2025 11:40:00 a. m.

Fecha Hora que Termina: 21/03/2025 2:20:00 p. m.

Cirugia urgente: ☐

Tiempo Quirúrgico(Minutos): 160

No Sala de Cirugía: 8

Profilaxis con

Tipo de Herida : Limpia-Contaminada

Tipo de Anestesia : Combinada

Antimicrobianos: ☒

Clasificación ASA: 2

Datos Adicionales: Prótesis / Implante ☐ CX Caderas ☐ CX Rodillas ☐ Laparotomia ☐ Fractura Abierta ☐ Clas. Fractura:

Cirugías: (Can: Cantidad, P: Cirugía Principal)

Cod. C.U.P.S	Cirugía	Via Abordaje	Can. P.
652301	RESECCION DE TUMOR DE OVARIO POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☒
544104	OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
541703	LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
669201	SALPINGO-OOFORECTOMIA BILATERAL POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☐
590201	URETEROLISIS CON LIBERACIÓN O REPOSICIONAMIENTO DE URÉTER	UNICA VIA	1 ☐
686001	HISTERECTOMIA RADICAL VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐

DESCRIPCION QUIRURGICA

Hallazgo Operatorio:

ABDOMEN DISTENDIDO

LIQUIDO SEROHEMATICO EN CAVIDAD ABDOMINAL 10000 CC

TUMOR PARAOVARICO IZQUIERDO DE 10*8 CM ROTO CON SANGRADO ACTIVO

UTERO DE TAMAÑO Y FORMA NORMAL

TROMPAS NORMALES
OVARIOS NORMALES
IMPLANTES ENDOMETRICOS EN FONDO DE SACO POSTERIOR, TORUS UTERINO , ABUNDANTES EN LIGAMENTOS UTERO
SACROS DE PREDIMINIO IZQUIERDO
VEJIGA , RECTO Y URETERES INDEMNES , HIGADO , BAZO, ESTOMAGO Y ASAS INTESTINALES DELGADAS Y GRUESAS
NORMALES. GOTERAS PARIETOCOLICAS Y CUPULAS DIAFRAGMATICAS LIBRES.
PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES, SANGRADO DE 200 CC, LIQUIDO LIBRE ABDOMINAL SEROHEMATICO DRENADO DE
10000 CC , ORINA CLARA AL FINALIZAR, CONTEO Y RECONTEO DE MATERIAL QUIRURGICO COMPLETO POR PARTE DE
INSTRUMENTADORA QUIRURGICA RESPONSABLE.

BIOPSIA POR CONGELACION : DRA RINA PATOLOGIA TUMOR DE CORDONES SEXUALES, DIAGNOSTICOS DEFINITIVO EN
MULTIPLES CORTES EN PARAFINA E INMUNOHISTOQUIMICA EN 12 MARCADORES .

Detalle Quirúrgico - Procedimientos:

PREVIA ASEPSIA Y ANTISEPSIA
COLOCACION DE CAMPOS ESTERILES
SE REALIZA :
INSICION INFRAUMBILICAL MEDIA
DISECCION POR PLANOS HASTA CAVIDAD
DRENAJE DE LIQUIDO ASCITICO SEROHEMATICO DE 1000 CC , TOMA DE MUESTRA PARA PATOLOGIA
IDENTIFICACION DE TUMOR PARA OVARICO DESCRITO
APERTURA Y DISECCION DE HOJA POSTERIOR DE LIGAMENTO ANCHO BILATERAL
IDENTIFICACION DE URETERES EN TODO SU RECORRIDO Y VASOS PELVICOS BILATERAL
IDENTIFICACION , PINZAMIENTO, COAGULACION Y CORTE DE LIGAMENTO INFUNDIBULO PELVICO IZQUIERDO , LIGAMENTO
UTERO OVARICO , TROMPA UTERINA IZQUIERDA, EXTRACCION DE TUMOR Y ENVIO A BIOPSIA POR CONGELACION
IDENTIFICACION , PINZAMIENTO, COAGULACION Y CORTE DE LIGAMENTO INFUNDIBULO PELVICO DERECHO
IDENTIFICACION , PINZAMIENTO, COAGULACION Y CORTE DE LIGAMENTO REDONDO , DISECCION DE HOJA ANTERIOR DE
LIGAMENTO ANCHO BILATERAL HASTA PLIEGUE VESICO UTERINO
DISECCION CAUDAL DE VEJIGA Y RECTO EN CARA POSTERIOR
DISECCION , IDENTIFICACION , COAGULACION Y CORTE DE VASOS UTERINOS BILATERALES CON LIGASURE A NIVEL DE
CRUCE DEL MISMO SOBRE LOS URETERES.
DISECCION Y LIBERACION DE URETERES DEL TUNEL DEL PARAMETRIO Y SE DISECA HASTA SU ENTRADA EN EL TRIGONO
VESICAL
SE PINZA CORTA Y LIGAN LIGAMENTOS UTEROSACROS Y PARAMETRIOS A NIVEL DE LA UNION DE LOS 2/3 INTERNOS CON
TERCIO EXTERNO CON LIGASURE
PINZAN CORTAN Y LIGAN ANGULOS DE CUPULA CON VICRYL 1 Y SE RESECA MANGO VAGINAL DE 2 CM , COMPLETANDO LA
ECTOMIA
SE REALIZA JARETA CON CAGUT CROMADO 2-0
SE REALIZA HEMOSTASIA
RESECCION DE IMPLANTE ENDOMETRIOSICO EN SEROSA DE RECTO
COLOCACION DE DREN DE BLAKE EN FOSA ILIACA IZQUIERDA
OMENTECTOMIA CON LIGASURE
REVISION DE HEMOSTASIA
CONTESTO DE INSTRUMENTAL Y CCOMPRESAS COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE
CIERRE DE FASCIA CON PDS 1, AFRONTAMIENTO DE TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO CON CATGUR CROMADO, PIEL CON
PROLENE 3-0

Complicaciones:

NINGUNA

Materiales (Que se Deben Cobrar Adicional a la Tarifa de los Qx):

LIGASURE

Compresas: COMPLETO

Gasas: COMPLETO

Conteo Material: COMPLETO

Tejidos Enviados a Anatomia Patologica:

Número de Muestras: 5

1. LAVADO PELVICO
2. TUMOR DE PARA OVARICO IZQUIERDO
3. UTERO CON 2 CM DE REBORDE VAGINAL MAS ANEXO DERECHO
4. OMENTO
5. IMPLANTE ENDOMETRIOSICO EN SEROSA DE RECTO

RECOMENDACIONES

-NADA VIA ORAL
-LACTATO RINGER IV A 100 ML/HORA
-DIETA LIQUIDA AL DESAYUNO Y BLANDA AL ALMUERZO
-ANALGESIA POR ANESTESIA
-OMEPRAZOL 40 MG IV CADA DIA

-METOCLOPRAMIDA IV 10 MG CADA 8 HORAS
-ENOXAPARINA IV 80 MG CADA 24 HORAS, INICIAR EN 24 HORAS
-MEDIAS ANTIEMBOLICAS
-TERAPIA RESPIRATORIA CON INCENTIVO RESPIRATORIO 2 VECES AL DIA
-TERAPIA FISICA INTEGRAL
-SONDA VESICAL A CISTOFLO
-CUIDADOS DE DREN DE BLAKE Y CUANTIFICACION
-CONTROL DE SIGNOS VITALES Y TEMPERATURA CADA 4 HORAS
-AVISAR CAMBIOS



Profesional: LUIS GUILLERMO CANO ARIAS

Especialidad: GINECOLOGIA ONCOLOGICA

Tarjeta Profesional # 12126929

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT: 891180268-0

INFORME QUIRURGICO

Ingreso: 1956062

Página 1/3

Número de Folio: 163

Ubicación: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO E.S.E. - QUIROFANOS

IDENTIFICACIÓN

Apellidos: RAYO OLAYA

Nombres: LIGIA

Dirección: CALLE 64A 1 - 59 B/ VILLA MARIA - NEIVA - NEIVA

Teléfono: 3177768063 - 3158670069

Profesión: NO APLICA REGISTRAR

Entidad Responsable: NUEVA EPS

Seguridad Social: NUEVA EPS

Tipo Documento: CC Numero: 36147062

Edad: 77 Años 02 Meses 03 Dias (18/01/1948)

Sexo: FEMENINO

Tipo Paciente: CONTRIBUTIVO

Tipo Afiliado: COTIZANTE

Estado Civil: CASADA

Grupo Étnico: NINGUNO DE LOS ANTERIORES

EQUIPO QUIRURGICO

Profesional	Perfil	Principal
LUIS GUILLERMO CANO ARIAS	Cirujano	☒
WILLIAM DIAZ HERRERA	Anestesiologo	☐
LINDA CATALINA MARTINEZ VALLEJO	Instrumentador	☐
SINDY MARGERY ARDILA MARTINEZ	Circulante	☐
CLERY FERNANDA CISNEROS PEREZ	RESIDENTE 2 AÑO	☐
MELYSSA DIAZ BOHORQUEZ	MEDICA INTERNA	☐

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Diagnósticos PRE-Operatorios:

CIE10	Diagnostico	Observaciones	Principal
D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO		☒
R520	DOLOR AGUDO		☐

Diagnósticos POS-Operatorios:

D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	☒
R520	DOLOR AGUDO	☐

INTERVENCION PRACTICADA/TIPO DE ANESTESIA Y DE HERIDA

Fecha Hora de Inicio: 21/03/2025 9:17:00 a. m.

Fecha Hora que Termina: 21/03/2025 10:53:00 a. m.

Cirugia urgente: ☐

Tiempo Quirúrgico(Minutos): 96

No Sala de Cirugía: 8

Profilaxis con

Tipo de Herida : Limpia-Contaminada

Tipo de Anestesia : Combinada

Antimicrobianos: ☒

Clasificación ASA: 3

Datos Adicionales: Prótesis / Implante ☐ CX Caderas ☐ CX Rodillas ☐ Laparotomia ☐ Fractura Abierta ☐ Clas. Fractura:

Cirugías: (Can: Cantidad, P: Cirugía Principal)

Cod. C.U.P.S	Cirugía	Via Abordaje	Can. P.
652302	RESECCION DE TUMOR DE OVARIO POR LAPAROSCOPIA	LAPAROSCOPIC A	1 ☒
684104	HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL AMPLIADA POR LAPAROSCOPIA	LAPAROSCOPIC A	1 ☐
669202	SALPINGO-OOFORECTOMIA BILATERAL POR LAPAROSCOPIA	LAPAROSCOPIC A	1 ☐
541704	LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO VIA LAPAROSCOPICA	LAPAROSCOPIC A	1 ☐

DESCRIPCION QUIRURGICA

Hallazgo Operatorio:

UTERO AUMENTADO DE TAMAÑO 1.5 VECES, DEFORMADO POR MASA INTRAMURAL DE 5 CM EN FONDO UTERINO. ANEXO IZQUIERDO NORMAL, ANEXO DERECHO CON MASA QUISTICA PARAOVARICA LOBULADA DE 8 CM, NO ADHERIDA, CAPSULA DELGADA, PARAMETRIOS LIBRES, FONDO DE SACO LIBRE , VEJIGA , RECTO Y URETERES INDEMNES , HIGADO , BAZO, ESTOMAGO Y ASAS INTESTINALES DELGADAS Y GRUESAS NORMALES. GOTERAS PARIETOCOLOCAS Y CUPULAS DIAFRAGMATICAS LIBRES.

PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES, SANGRADO DE 50 CC, ORINA CLARA AL FINALIZAR, CONTEO Y RECONTEO DE MATERIAL QUIRURGICO COMPLETO POR PARTE DE INSTRUMENTADORA QUIRURGICA RESPONSABLE.

DIAGNOSTICO: BIOPSIA POR CONGELACION DOCTORA MARYURI HERRERA PATOLOGA: TUMOR PARAOVARICO DERECHO , QUISTE PARATUBARICO , DIAGNOSTICO DEFINITIVO DE MULTIPLES CORTES EN PARAFINA.

Detalle Quirúrgico - Procedimientos:

BAJO ANESTESIA COMBINADA, PREVIA ASEPSIA, CAMPOS ESTERILES, CATETERISMO VESICAL Y UTILIZACION DE PROTOCOLOS INSTITUCIONALES PARA COVID 19, SE REALIZA COLOCACION DE MANIPULADOR UTERINO POR VIA VAGINAL. LUEGO SE COLOCA TROCASR UMBILICAL DE 12 MM A CAVIDAD MEDIANTE TECNICA ABIERTA DE HASSON SE INSUFLA NEUMOPERITONEO DE CO2 HASTA PRESION DE 12 MMHG, SE INTRODUCE CAMARA Y LENTE DE 30 ° Y SE REVIS A EXHAUSTIVAMENTE EL AREA CIRCUNSCRITA AL SITIO DE INGRESO DEL TROCAR, DESCARTANDOSE SOLUCION DE CONTINUIDAD EN LAS ESTRUCTURAS VECINAS. SE IDENTIFICAN ESTRUCTURAS PELVICAS Y ABDOMINALES CON LOS HALLAZGOS DESCRITOS. SE COLOCAN TROCARES AUXILIARES DE 5 MM EN FOSA ILIACA IZQUIERDA Y EN 12 MM EN FLANCO IZQUIERDO BAJO VISION DIRECTA SE COLOCA POSICION DE TRENDELEMBURG Y SE RECHAZAN LAS ASAS INTESTINALES DE LA CAVIDAD PELVICA. SE REALIZA LAVADO PELVICO. SE ABRE HOJA POSTERIOR DEL PERITONEO , SE IDENTIFICAN VASOS PELVICOS Y URETERES, SE ABRE FOSA PARAVESICAL Y PARARECTAL, SE RESECA LIGAMENTO ACNHO CIRCUNDANTE A LA MASA TUMORAL PARAOVARICA DERECHA DESDE EL LIGAMENTO REDONODO HASTE L NIVEL DE LA DIVISION DE LA ILIACA COMUN DERECHA. SE PINZAN , CORTAN Y LIGAN CON LIGASURE LIGAMENTOS INFUNDIBULOPELVICOS Y LIGAMENTO REDONDO , SE ABRE HOJA ANTERIOR DE PERITONEO Y SE RECHAZA LA VEJIGA Y EN CARA POSTERIOR EL RECTO. SE PINZAN , CORTAN Y LIGAN VASOS UTERINOS SOBRE LA COPA MANIPULADOR CON LIGASURE , SE PINZAN CORTAN Y LIGAN INSERCIÓN DE LIGAMENTOS UTEROSACROS Y PARMETRIOS CON LIGASURE. SE INSIDE CUPULA VAGINAL CON MONOPOLAR SOBRE LA COPA, RESECANDOSE MANGO VAGINAL DE 1 CM, COMPLETANDOSE LA ECTOMIA. SE EXTRAE UTERO Y ANEXOS POR VIA VAGINAL. SE OCLUYE CANAL VAGINAL. SE REALIZA SUTURA DE LA CUPULA VAGINAL CON STRATAFIX 2-0 BAJO TECNICA DE LAPAROSCOPIA SIN COMPLICACIONES. SE REVIS A HEMOSTASIA, SE ORDENA A LA INSTRUMENTADORA EL CONTEO Y RECONTEO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EL CUAL ES INFORMADO COMO COMPLETO. SE RETIRAN TROCARES BAJO VISION DIRECTA Y SE DRENA NEUMOÉRITONEO. SE SUTURA FASCIA DE INCISIONES DE 12 MM CON VICRYL 0 Y PIEL CON PROLENE 3-0. NO COMPLICACIONES

Complicaciones:

NINGUNA

Materiales (Que se Deben Cobrar Adicional a la Tarifa de los Qx):

LIGASURE

Compresas: COMPLETO POR PARTE DE INSTRUMENTADORA QUIRURGICA RESPONSABLE.

Gasas: COMPLETO POR PARTE DE INSTRUMENTADORA QUIRURGICA RESPONSABLE.

Conteo Material: COMPLETO POR PARTE DE INSTRUMENTADORA QUIRURGICA RESPONSABLE.

Tejidos Enviados a Anatomia Patologica:

Número de Muestras: 3

UTERO Y ANEXOS (TROMPAS Y OVARIOS) Y MANGO VAGINAL.
LAVADO PELVICO.
LIQUIDO INTRQUISTICO

RECOMENDACIONES

- NADA VIA ORAL
- LACTATO RINGER IV A 100 ML/HORA
- DIETA LIQUIDA AL DESAYUNO Y BLANDA AL ALMUERZO
- ANALGESIA POR ANESTESIA
- OMEPRAZOL 40 MG IV CADA DIA
- METOCLOPRAMIDA IV 10 MG CADA 8 HORAS
- ENOXAPARINA IV 60 MG CADA 12 HORAS, INICIAR EN 24 HORAS
- MEDIAS ANTIEMBOLICAS
- TERAPIA RESPIRATORIA CON INCENTIVO RESPIRATORIO 2 VECES AL DIA
- TERAPIA FISICA INTEGRAL
- SONDA VESICAL A CISTOFLO
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y TEMPERATURA CADA 4 HORAS
- AVISAR CAMBIOS



Profesional: LUIS GUILLERMO CANO ARIAS

Especialidad: GINECOLOGIA ONCOLOGICA

Tarjeta Profesional # 12126929

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT: 891180268-0

INFORME QUIRURGICO

Ingreso: 1955735

Página 1/3

Número de Folio: 30

Ubicación: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO E.S.E. - QUIROFANOS

IDENTIFICACIÓN

Apellidos: LOPEZ RAMIREZ

Nombres: CARMEN

Dirección: BARRIO QUINCE DE JUNIO - CARTAGENA DEL CHAIRA
- CARTAGENA DEL CHAIRA

Teléfono: - 3209475794

Profesión: NO APLICA REGISTRAR

Entidad Responsable: ASMET SALUD EPS SAS

Seguridad Social: ASMET SALUD EPS SAS

Tipo Documento: CC Numero: 1106395678

Edad: 64 Años 06 Meses 17 Dias (5/09/1960)

Sexo: FEMENINO

Tipo Paciente: SUBSIDIADO

Tipo Afiliado: NO APLICA

Estado Civil: VIUDA

Grupo Étnico: NINGUNO DE LOS ANTERIORES

EQUIPO QUIRURGICO

Profesional	Perfil	Principal
LUIS GUILLERMO CANO ARIAS	Cirujano	☒
WILLIAM DIAZ HERRERA	Anestesiologo	☐
DIANA MARCELA MENDEZ CORDOBA	Instrumentador	☐
DISNEY LOAIZA GIRALDO	Circulante	☐
CLERY FERNANDA CISNEROS PEREZ	RESIDENTE II AÑO	☐
VIVIANA CUELLAR CORREA	INTERNA	☐

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Diagnósticos PRE-Operatorios:

CIE10	Diagnostico	Observaciones	Principal
C531	TUMOR MALIGNO DE EXOCERVIX		☒
R520	DOLOR AGUDO		☐

Diagnósticos POS-Operatorios:

C531	TUMOR MALIGNO DE EXOCERVIX	☒
R520	DOLOR AGUDO	☐

INTERVENCION PRACTICADA/TIPO DE ANESTESIA Y DE HERIDA

Fecha Hora de Inicio: 22/03/2025 10:03:00 a. m.

Fecha Hora que Termina: 22/03/2025 12:16:00 p. m.

Cirugia urgente: ☐

Tiempo Quirúrgico(Minutos): 133

No Sala de Cirugía: 4

Profilaxis con

Tipo de Herida : Limpia-Contaminada

Tipo de Anestesia : Combinada

Antimicrobianos: ☒

Clasificación ASA: 3

Datos Adicionales: Prótesis / Implante ☐ CX Caderas ☐ CX Rodillas ☐ Laparotomia ☐ Fractura Abierta ☐ Clas. Fractura:

Cirugías: (Can: Cantidad, P: Cirugía Principal)

Cod. C.U.P.S	Cirugía	Via Abordaje	Can. P.
686001	HISTERECTOMIA RADICAL VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☒
405406	LINFADENECTOMIA RADICAL PELVICA VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
405502	RESECCION RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS RETROPERITONEALES VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
669201	SALPINGO-OOFORECTOMIA BILATERAL POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☐
544104	OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
590201	URETEROLISIS CON LIBERACIÓN O REPOSICIONAMIENTO DE URÉTER	UNICA VIA	1 ☐
541703	LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐

DESCRIPCION QUIRURGICA

Hallazgo Operatorio:

UTERO NORMAL CON LESION TUMORAL CERVICAL DE 3CM. PARAMETRIOS LIBRES ACORTADO EL IZQUIERDO SIN NODULACIONES. ANEXOS NORMALES. FONDO DE SACO LIBRE. VEJIGA, RECTO Y URETERES INDEMNES. APÉNDICE

NORMAL. EPIPLON NORMAL. HIGADO, BAZO, ESTÓMAGO Y ASAS INTESTINALES DELGADAS Y GRUESAS NORMALES. GOTERAS PARIETOCÓLICAS Y CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS LIBRES. GANGLIOS PÉLVICOS Y PARAÓRTICOS LIBRES. PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES. SANGRADO 300CC. ORINA CLARA AL FINALIZAR. CONTEO Y RECONTEO DE COMPRESAS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Detalle Quirúrgico - Procedimientos:

BAJO ANESTESIA COMBINADA PREVIA ASEPSIA DEL CAMPO OPERATORIO Y CATETERISMO VESICAL Y UTILIZACIÓN DE PROTOCOLOS INSTITUCIONALES PARA COVID-19, SE REALIZA INCISIÓN MEDIANA INFRA Y SUPRAUMBILICAL, SE INCIDE POR PLANOS HASTA CAVIDAD. SE IDENTIFICAN ESTRUCTURAS PÉLVICAS Y ABDOMINALES CON LOS HALLAZGOS DESCRITOS. SE REALIZA LAVADO PÉLVICO. SE LIBERA EL URETER DE LA TRACCIÓN DEL PARAMETRIO IZQUIERDO POR EL ACORTAMIENTO POR LA MASA CERVICAL SIN COMPLICACIONES REPOSICIONÁNDOLO A SU TRAYECTO NORMAL. SE ABRE HOJA POSTERIOR DEL PERITONEO Y SE IDENTIFICAN VASOS PÉLVICOS Y URETERES, SE ABRE FOSA PARAVESICAL Y PARARECTAL. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN CON LIGASURE LIGAMENTOS INFUNDIBULOPELVICOS Y LIGAMENTOS REDONDOS. SE ABRE HOJA ANTERIOR DEL PERITONEO Y SE RECHAZA DISTALMENTE LA VEJIGA Y EN CARA POSTERIOR EL RECTO. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN VASOS UTERINOS EN SU NACIMIENTO CON LIGASURE. SE LIBERAN LOS URETERES DEL TUNEL DEL PARAMETRIO BILATERALMENTE Y SE DISECAN HASTA SU ENTRADA EN EL TRIGONO VESICAL. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN CON LIGASURE LIGAMENTOS UTEROSACROS Y PARAMETRIOS EN LA UNIÓN DE LOS 2/3 INTERNOS CON EL TERCIO EXTERNO. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN CON VICRYL 1 ANGULOS DE LA CÚPULA Y SE RESECA MANGO VAGINAL DE 3CM COMPLETÁNDOSE LA ECTOMIA. SE REALIZA JARETA CON CC0. SE REVISLA LA HEMOSTASIA. SE REALIZA LINFADENECTOMIA PELVICA BILATERAL (ILIACOS EXTERNOS, HIPOGASTRICOS Y OBTURADORES) SIN COMPLICACIONES. SE RESECAN GANGLIOS ILIACOS COMUNES DERECHOS. SE REALIZA LINFADENECTOMIA RETROPERITONEAL PARAORTICA DESDE LA DIVISIÓN DE LAS ILIACAS COMUNES HASTA NIVEL DE LA DESEMBOCADURA DE LA VENA OVARICA EN LA CAVA SIN COMPLICACIONES. SE REALIZA OMENTECTOMIA PARCIAL CON LIGASURE. SE REVISLA HEMOSTASIA. SE LAVA CAVIDAD PELVICA CON 300CC SSN HASTA OBTENER RETORNO CLARO. SE RETIRAN COMPRESAS Y SE REVISLA EXHAUSTIVAMENTE LA CAVIDAD DESCARTANDO LA PRESENCIA DE CUERPO EXTRAÑO Y SE ORDENA A LA INSTRUMENTADORA RESPONSABLE EL CONTEO Y RECONTEO DE COMPRESAS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EL CUAL ES INFORMADO COMO COMPLETO POR LO QUE SE CIERRA POR PLANOS HASTA PIEL. NO COMPLICACIONES.

Complicaciones:

NINGUNA

Materiales (Que se Deben Cobrar Adicional a la Tarifa de los Qx):

LIGASURE.

Compresas: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Gasas: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Conteo Material: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Tejidos Enviados a Anatomia Patologica:

Número de Muestras: 11

UTERO, ANEXOS (TROMPAS Y OVARIOS) Y MANGO VAGINAL. EPIPLON. GANGLIOS PELVICOS BILATERALES (ILIACOS EXTERNOS, HIPOGASTRICOS Y OBTURADORES). GANGLIOS ILIACOS COMUNES DERECHOS. GANGLIOS PARAORTICOS. LAVADO PELVICO.

RECOMENDACIONES

NADA VIA ORAL
LACTATO RINGER 100CC/HORA
DIETA LIQUIDA AL ALMUERZO
ANALGESIA POR ANESTESIA
OMEPRAZOL 40MG IV/DIA
METOCLOPRAMIDA 10MG IV CADA 8 HORAS
ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEO/DIA INICIAR EN 12 HORAS
MEDIAS ANTIEMBOLICAS
TERAPIA RESPIRATORIA CON INCENTIVO RESPIRATORIO 2 VECES/DIA
TERAPIA FISICA INTEGRAL 2 VECES/DIA
SONDA VESICAL A CISTOFLO
CSV Y T CADA 4 HORAS
AVISAR CAMBIOS.



Profesional: LUIS GUILLERMO CANO ARIAS

Especialidad: GINECOLOGIA ONCOLOGICA

Tarjeta Profesional # 12126929

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT: 891180268-0

INFORME QUIRURGICO

Ingreso: 1959729

Página 1/2

Número de Folio: 51

Ubicación: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO E.S.E. - QUIROFANOS

IDENTIFICACIÓN

Apellidos: LOZANO GARCIA
Nombres: MARTHA XIMENA
Dirección: CRA 2 A 2 - 56 - GARZON - GARZON
Teléfono: 3118397322 - 3113835995
Profesión: NO APLICA REGISTRAR
Entidad Responsable: NUEVA EPS
Seguridad Social: NUEVA EPS

Tipo Documento: CC **Numero:** 55067909
Edad: 43 Años 05 Meses 20 Dias (6/10/1981)
Sexo: FEMENINO
Tipo Paciente: CONTRIBUTIVO
Tipo Afiliado: COTIZANTE
Estado Civil: SOLTERA
Grupo Étnico: NINGUNO DE LOS ANTERIORES

EQUIPO QUIRURGICO

Profesional	Perfil	Principal
CARLOS ANDRES BARRERA NEIRA	Cirujano	☒
MONICA NOHEMI ANGULO CARVALLO	Cirujano	☐
EUGENIO MEDINA TRUJILLO	Anestesiologo	☐
CATALINA SILVA ESQUIVEL	Instrumentador	☐
KERLY JOHANNA YAÑEZ CAICEDO	Circulante	☐
CLERY FERNANDA CISNEROS PEREZ	R G/O	☐
EDWIN SAMIR MOTATO RAMIREZ	R G/O	☐

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Diagnósticos PRE-Operatorios:

CIE10	Diagnostico	Observaciones	Principal
D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION		☒

Diagnósticos POS-Operatorios:

D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	☒
------	--	-------------------------------------

INTERVENCION PRACTICADA/TIPO DE ANESTESIA Y DE HERIDA

Fecha Hora de Inicio: 26/03/2025 8:20:00 a. m. **Fecha Hora que Termina:** 26/03/2025 9:59:00 a. m. **Cirugia urgente:** ☐
Tiempo Quirúrgico(Minutos): 99 **No Sala de Cirugía:** 3 **Profilaxis con**
Tipo de Herida : Limpia-Contaminada **Tipo de Anestesia :** General **Antimicrobianos:** ☒

Clasificación ASA: 2

Datos Adicionales: Prótesis / Implante ☐ CX Caderas ☐ CX Rodillas ☐ Laparotomia ☐ Fractura Abierta ☐ **Clas. Fractura:**

Cirugías: (Can: Cantidad, P: Cirugía Principal)

Cod. C.U.P.S	Cirugía	Via Abordaje	Can. P.
684020	HISTERECTOMIA TOTAL POR LAPAROSCOPIA	LAPAROSCOPIC A	1 ☒
665002	SALPINGECTOMIA BILATERAL TOTAL POR LAPAROSCOPIA	LAPAROSCOPIC A	1 ☐
682404	MIOMECTOMIA UTERINA UNICA O MULTIPLE POR HISTEROSCOPIA	LAPAROSCOPIC A	1 ☐
541704	LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO VIA LAPAROSCOPICA	LAPAROSCOPIC A	1 ☐
653102	OOFORECTOMIA UNILATERAL POR LAPAROSCOPIA	LAPAROSCOPIC A	1 ☐

DESCRIPCION QUIRURGICA

Hallazgo Operatorio:

- UTERO MIOMATOSO DE 16 X 10 CM, CON MULTIPLES MIOMAS, FUNDICO DE 6CM APROX, POSTERIOR DE 4CM Y LATERAL DE 4 CM APROX
- TROMPAS UTERINAS NORMALES.
- OVARIOS IZQUIERDO NORMAL, OVARIO DERECHO CON QUISTE FOLICULAR

Impreso el 26/03/2025 a las 16:37:31 Por el Usuario 7715189 - JULIO CESAR GUTIERREZ MARIN

Indigo Crystal.Net - Powered By INDIGO TECHNOLOGIES - to ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Nit: 891180268-0

4. FONDO DE SACO DE DOUGLAS, LIGAMENTO UTEROSACROS, FOSAS OVARICAS, LIGAMENTOS ANCHOS, LIGAMENTOS REDONDEO NORMALES
5. NO FOCOS ENDOMETRIOSICOS EN FOSAS OVARICAS, LIGAMENTOS UTEROSACROS BILATERALES NI TORUS UTERINO.
6. ASAS INTESTINALES Y ADBOMEN SUPERIOR MACROSCOPICAMENTE NORMAL

Detalle Quirúrgico - Procedimientos:

1. ASEPSIA Y ANTISEPSIA, SONDA VESICAL A CISTOFLO, TIEMPO VAGINAL CON COLPOTOMIZADOR
2. INFILTRACION SUPRAUMBILICAL CON BUPIVACAINA, INCISION DE 12 mm, PASO DE TROCAR PRIMARIO CON TECNICA CERRADO DIRECTA, CO2 15 mmHg. VISUALIZACION DE HALLAZGOS
3. PASO DE TROCARES ACCESORIOS BAJO VISION DIRECTA, 5 mm #2, 11mm #1.
4. SE REALIZA LAVADO PELVICO Y SE TOMA MUESTRA CON TUBO TRAMPA.
5. COAGULACION Y CORTE CON LIGASURE DE LIGAMENTO INFUNDIBULO PELVICO DERECHO, MESOSALPINX, LIGAMENTO UTEROOVARICOS, VASOS UTERO OVARICOS, LIGAMENTOS REDONDOS, HOJA ANTERIOR Y POSTERIOR DE LIGAMENTOS ANCHOS BILATERALMENTE
6. DISECCION DE ESPACIO VESICO VAGINAL.
7. COAGULACION Y CORTE CON LIGASURE DE VASOS UTERINOS BILATERALES
8. COAGULACION Y CORTE CON LIGASURE Y MANIOBRAS DE TRACCION Y CONTRATRACCION, PARA REALIZACION DE MIOMECTOMIA DE MIOMAS DESCRITOS.
9. COLPOTOMIA CON ENERGIA MONOPOLAR Y EXTRACCION DE UTERO Y MIOMAS POR VAGINA
10. RAFIA DE CUPULA VAGINAL EN 2 PLANOS CON STRATAFIX.
11. LAVADO DE CAVIDAD PELVICA CON SSN, REVISION DE HEMOSTASIA
12. EXTRACCION DE TROCARES BAJO VISION DIRECTA, CO2, TROCAR UMBILICAL.
13. RAFIA DE APONEUROSIS UMBILICAL Y PARARECTAL DERECHA, SUTURA DE HERIDAS DE PIEL CON PROLENE 3-0

Complicaciones:

NINGUNA

Materiales (Que se Deben Cobrar Adicional a la Tarifa de los Qx):SET DE TROCARES
LIGASURE**Compresas:** COMPLETO**Gasas:** COMPLETO**Conteo Material:** COMPLETO**Tejidos Enviados a Anatomia Patologica:****Número de Muestras:** 7

UTERO, TROMPA IZQUIERDA, ANEXO DERECHO, MIOMAS X3, LAVADO PERITONEAL

RECOMENDACIONES

HOSPITALIZAR EN GINECOLOGIA
DIETA LIQUIDA EN 2 HORAS*****
RINGER 60 CC/H
DIPIRONA 2 GR IV CADA 8 HORAS
HIOSCINA 20MG IV CADA 8 HORAS
ENOXAPARINA 40MG SC CADA 24 HORAS INICIAR EN 12 HORAS
OMEPRAZOL 40MG IV CADA 24 HORAS
ONDASENTRON 8 MG IV CADA 12 HORAS
USO DE MEDIAS DE COMPRESION
DEAMBULACION TEMPRANA ASISTIDA
CONTROL DE SIGNOS VITALES AVISAR CAMBIOS
RETIRO DE SONDA VESICAL EN 4 HORAS EN RECUPERACION*****

**Profesional:** CARLOS ANDRES BARRERA NEIRA**Especialidad:** GINECOLOGIA ONCOLOGICA**Tarjeta Profesional #** 191-2001

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT: 891180268-0

INFORME QUIRURGICO

Ingreso: 1959911

Página 1/3

Número de Folio: 8

Ubicación: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO E.S.E. - QUIROFANOS

IDENTIFICACIÓN

Apellidos: RIVERA AYA
Nombres: ERIKA CONSTANZA
Dirección: CLL 20 36 04 - NEIVA - NEIVA
Teléfono: 3156181871 -
Profesión: NO APLICA REGISTRAR
Entidad Responsable: E.P.S. SANITAS S.A.S
Seguridad Social: E.P.S. SANITAS S.A.S

Tipo Documento: CC Numero: 1075253880
Edad: 33 Años 09 Meses 14 Dias (13/06/1991)
Sexo: FEMENINO
Tipo Paciente: CONTRIBUTIVO
Tipo Afiliado: BENEFICIARIO
Estado Civil: CASADA
Grupo Étnico:

EQUIPO QUIRURGICO

Profesional	Perfil	Principal
LUIS GUILLERMO CANO ARIAS	Cirujano	☒
WILLIAM DIAZ HERRERA	Anestesiologo	☐
DIANA MARCELA MENDEZ CORDOBA	Instrumentador	☐
DEICY YAGUE PEREZ	Circulante	☐
MARIA DEL PILAR ANACONA GUERRERO	Circulante	☐
EDWIN SAMIR MOTATO RAMIREZ	RESIDENTE II AÑO	☐
GREIZ IDANIA ARMERO BASTIDAS	INTERNA	☐

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Diagnósticos PRE-Operatorios:

CIE10	Diagnostico	Observaciones	Principal
C531	TUMOR MALIGNO DE EXOCERVIX		☒
R520	DOLOR AGUDO		☐

Diagnósticos POS-Operatorios:

C531	TUMOR MALIGNO DE EXOCERVIX	☒
R520	DOLOR AGUDO	☐

INTERVENCION PRACTICADA/TIPO DE ANESTESIA Y DE HERIDA

Fecha Hora de Inicio: 27/03/2025 9:17:00 a. m. Fecha Hora que Termina: 27/03/2025 12:35:00 p. m. Cirugia urgente: ☐
Tiempo Quirúrgico(Minutos): 198 No Sala de Cirugía: 4 Profilaxis con
Tipo de Herida : Limpia-Contaminada Tipo de Anestesia : Combinada Antimicrobianos: ☒
Clasificación ASA: 3

Datos Adicionales: Prótesis / Implante ☐ CX Caderas ☐ CX Rodillas ☐ Laparotomia ☐ Fractura Abierta ☐ Clas. Fractura:

Cirugías: (Can: Cantidad, P: Cirugía Principal)

Cod. C.U.P.S	Cirugía	Via Abordaje	Can. P.
686001	HISTERECTOMIA RADICAL VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☒
405406	LINFADENECTOMIA RADICAL PELVICA VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
405502	RESECCION RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS RETROPERITONEALES VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
665001	SALPINGECTOMIA BILATERAL TOTAL POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☐
657803	OOFOROPEXIA BILATERAL POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☐
544104	OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
590201	URETEROLISIS CON LIBERACIÓN O REPOSICIONAMIENTO DE URÉTER	UNICA VIA	1 ☐
541703	LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐

DESCRIPCION QUIRURGICA

Hallazgo Operatorio:

UTERO NORMAL. CUELLO UTERINO CON MASA EXOENDOFITICA DE 4X3CM. ANEXOS NORMALES. FONDO DE SACO LIBRE. PARAMETRIOS LIBRES ACORTADO EL IZQUIERDO SIN NODULACIONES. VEJIGA, RECTO Y URETERES INDEMNES. URETER IZQUIERDO RETRAIDO POR PROCESO ADHERENCIAL HACIA EL LIGAMENTO UTEROSACRO IZQUIERDO QUE SE LIBERA Y REPOSICIONA A SU TRAYECTO NORMAL. APÉNDICE NORMAL. EPIPLON NORMAL. HIGADO, BAZO, ESTÓMAGO Y ASAS INTESTINALES DELGADAS Y GRUESAS NORMALES. GANGLIOS PELVICOS Y PARAORTICOS DE 1X1CM. PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES. SANGRADO 300CC. ORINA CLARA AL FINALIZAR 700CC. CONTEO Y RECONTEO DE COMPRESAS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Detalle Quirúrgico - Procedimientos:

BAJO ANESTESIA COMBINADA PREVIA ASEPSIA DEL CAMPO OPERATORIO Y CATETERISMO VESICAL, Y UTILIZACIÓN DE PROTOCOLOS INSTITUCIONALES PARA COVID-19, SE RELIZA INCISIÓN MEDIANA INFRAUMBILICAL, SE INCIDE POR PLANOS HASTA CAVIDAD, SE IDENTIFICAN ESTRUCTURAS PÉLVICAS Y ABDOMINALES CON LOS HALLAZGOS DESCRITOS. SE REALIZA LAVADO PELVICO. SE ABRE HOJA POSTERIOR DEL PERITONEO Y SE IDENTIFICAN VASOS PÉLVICOS Y URETERES. SE ABRE FOSA PARAVESICAL Y PARARRECTAL. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN MESOSALPINX CON LIGASURE RESECANDOSE TROMPAS UTERINAS BILATERALES. SE LIBERA EL URETER DE LA TRACCIÓN QUE LE REALIZA EL PARAMETRIO IZQUIERDO Y EL CERVIX TUMORAL LATERAL IZQUIERDO SIN COMPLICACIONES. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN CON LIGASURE CUERNOS UTERINOS CONSERVANDOSE LOS OVARIOS. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN CON LIGASURE LIGAMENTOS REDONDOS, SE ABRE HOJA ANTERIOR DEL PERITONEO Y SE RECHAZA LA VEJIGA Y EN CARA POSTERIOR EL RECTO. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN VASOS UTERINOS CON LIGASURE A NIVEL DE SU NACIMIENTO. SE LIBERAN LOS URETERES DEL TUNEL DEL PARAMETRIO BILATERALMENTE Y SE DISECAN HASTA SU ENTRADA EN EL TRIGONO VESICAL. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN LIGAMENTOS UTEROSACROS Y PARAMETRIOS EN LA UNIÓN DE LOS 2/3 INTERNOS CON EL TERCIO EXTERNO CON LIGASURE. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN CON VICRYL 1 ANGULOS DE LA CÚPULA Y SE RESECA MANGO VAGINAL DE 3CM COMPLETANDOSE LA ECTOMIA. SE REALIZA JARETA CON CC0 Y SE REVISAS HEMOSTASIA. SE REALIZA LINFADENECTOMIA PELVICA BILATERAL (ILIACOS EXTERNOS, HIPOGASTRICOS Y OBTURADORES) SIN COMPLICACIONES. SE RESECAN GANGLIOS ILIACOS COMUNES SIN COMPLICACIONES. SE REALIZA LINFADENECTOMIA RETROPERITONEAL PARAORTICO DESDE LA DIVISIÓN DE LAS ILIACAS COMUNES HASTA LA SALIDA DE LA MESENTERICA INFERIOR. SIN COMPLICACIONES. SE REALIZA OMENTECTOMIA PARCIAL CON LIGASURE SIN COMPLICACIONES. SE REVISAS HEMOSTASIA. SE LAVA CAVIDAD PELVICA CON 400CC DE SSN HASTA OBTENER RETORNO CLARO. SE RETIRAN COMPRESAS Y SE REVISAS EXHAUSTIVAMENTE LA CAVIDAD DESCARTANDO LA PRESENCIA DE CUERPO EXTRAÑO Y SE ORDENA A LA INSTRUMENTADORA RESPONSABLE EL CONTEO RECONTEO DE COMPRESAS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EL CUAL ES INFORMADO COMO COMPLETO POR LO QUE SE CIERRA POR PLANOS HASTA PIEL. NO COMPLICACIONES

Complicaciones:

NINGUNA

Materiales (Que se Deben Cobrar Adicional a la Tarifa de los Qx):

LIGASURE

Compresas: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.**Gasas:** COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.**Conteo Material:** COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.**Tejidos Enviados a Anatomia Patologica:****Número de Muestras:** 12

UTERO, TROMPAS UTERINAS(DERECHA E IZQUIERDA), MANGO VAGINAL. EPIPLON. GANGLIOS PELVICOS BILATERALES (ILIACOS EXTERNOS, HIPOGASTRICOS Y OBTURADORES). QUISTE FOLICULAR OVARICO. GANGLIO ILIACO COMUN DERECHO. GANGLIOS PARAORTICOS. LAVADO PELVICO.

RECOMENDACIONES

NADA VIA ORAL
LACTATO RINGER 100CC/HORA
DIETA LIQUIDA AL ALMUERZO MAÑANA
ANALGESIA POR ANESTESIA
METOCLOPRAMIDA 10MG IV CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 40MG IV/DIA
ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEO/DIA INICIAR EN 12 HORAS
MEDIAS ANTIEMBOLICAS
TERAPIA RESPIRATORIA CON INCENTIVO RESPIRATORIO 2 VECES/DIA
TERAPIA FISICA INTEGRAL 2 VECES/DIA
SONDA VESICAL A CISTOFLO
CSV Y T CADA 4 HORAS
AVISAR CAMBIOS



Profesional: LUIS GUILLERMO CANO ARIAS

Especialidad: GINECOLOGIA ONCOLOGICA

Tarjeta Profesional # 12126929

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT: 891180268-0

INFORME QUIRURGICO

Ingreso: 1947578

Página 1/2

Número de Folio: 116

Ubicación: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO E.S.E. - QUIROFANOS

IDENTIFICACIÓN

Apellidos: BUSTAMANTE MORALES	Tipo Documento: CC Numero: 29771498
Nombres: MARIA ROSALBINA	Edad: 71 Años 03 Meses 26 Dias (1/12/1953)
Dirección: VEREDA HORIZONTE - PALERMO - PALERMO	Sexo: FEMENINO
Teléfono: - 3208608277	Tipo Paciente: SUBSIDIADO
Profesión: NO APLICA REGISTRAR	Tipo Afiliado: NO APLICA
Entidad Responsable: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	Estado Civil: VIUDA
Seguridad Social: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	Grupo Étnico: NINGUNO DE LOS ANTERIORES

EQUIPO QUIRURGICO

Profesional	Perfil	Principal
LUIS GUILLERMO CANO ARIAS	Cirujano	☒
WILLIAM DIAZ HERRERA	Anestesiologo	☐
VALENTINA CAMARGO TORRES	Instrumentador	☐
MARIA DEL PILAR ANACONA GUERRERO	Circulante	☐
EDWIN SAMIR MOTATO RAMIREZ	R G/O	☐
GREIZ IDANIA ARMERO BASTIDAS	MD INTERNA	☐

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Diagnósticos PRE-Operatorios:

CIE10	Diagnostico	Observaciones	Principal
C519	TUMOR MALIGNO DE LA VULVA, PARTE NO ESPECIFICADA		☐

Diagnósticos POS-Operatorios:

C519	TUMOR MALIGNO DE LA VULVA, PARTE NO ESPECIFICADA	☐
------	--	--------------------------

INTERVENCION PRACTICADA/TIPO DE ANESTESIA Y DE HERIDA

Fecha Hora de Inicio: 27/03/2025 2:17:00 p. m.	Fecha Hora que Termina: 27/03/2025 4:00:00 p. m.	Cirugia urgente: ☐
Tiempo Quirúrgico(Minutos): 103	No Sala de Cirugía: 4	Profilaxis con Antimicrobianos: ☒
Tipo de Herida : Limpia-Contaminada	Tipo de Anestesia : General	
Clasificación ASA: 2		
Datos Adicionales: Prótesis / Implante ☐ CX Caderas ☐ CX Rodillas ☐ Laparotomia ☐ Fractura Abierta ☐ Clas. Fractura:		

Cirugías: (Can: Cantidad, P: Cirugía Principal)

Cod. C.U.P.S	Cirugía	Via Abordaje	Can. P.
715007	VULVECTOMIA RADICAL	UNICA VIA	1 ☒

DESCRIPCION QUIRURGICA

Hallazgo Operatorio:

GRAN LESIÓN A NIVEL DE VULVA DE PREDOMINIO IZQUIERDA QUE COMPROMETE LABIO MAYOR Y MENOR EN SUS 2/3 INFERIORES. Y LA VULVA DERECHA EN SU TERCIO INFERIOR INFILTRANDO EL LABIO MAYOR Y MENOR. NO INFILTRA LA VAGINA NI EL INTROITO VAGINAL. INFILTRA EL PERINE EN UN DIAMETRO DE 7CM, EL ANO SIN INFILTRAR LA MUCOSA RECTAL , LA REGIÓN PERIANAL Y EL ÁREA GLÚTEA CIRCUNDANTE HASTA 10CM POR ENCIMA DEL ANO SIGUIENDO EL SURCO INTERGLÚTEO Y EN UN DIAMETRO DE 8CM. LA LESIÓN ES DE BORDES ELEVADOS E IRREGULARES DE ASPECTO CONDILOMATOSO.

Detalle Quirúrgico - Procedimientos:

BAJO ANESTESIA GENERAL
PREVIA ASEPSIA Y ANTISEPSIA COLOCACION DE CAMPOS ESTERILES
CATERISMO VESICAL
SE REALIZA INSCION EN HERRADUDA CON CANCAVIDAD SUPERIOR DISECANDO LABIO MAYOR UY MENOR BILATERAL DEDE EL TERCIO MEDIO AL INFERIOR

SE DISECA TEJIDO PERINEAL CONSERVANDOSE ESFINTER ANAL, MUSCULOS BULBOCAVERNOSOS E ISQUICAVERNOSO
CONTINUA PROCEDIMIENTO POR COLOPROCTOLOGIA LA RESECCION PERIANAL E INTERGLUTEA CON MARGEN DE SEGURIDA
DE MINIMO 1 CM EN LOS BORDES
POSTERIOR CONTINUA POR CIRUGIA PLASTICA PARA CORRECCION DEL DEFECTO

Complicaciones:

NINGUNA

Materiales (Que se Deben Cobrar Adicional a la Tarifa de los Qx):

NO

Compresas: COMPLETO**Gasas:** 0**Conteo Material:** COMPLETO**Tejidos Enviados a Anatomia Patologica:****Número de Muestras:** 1HEMIVULVA INFERIOR IZQUIERDA 2 SEDAS DERECHA 1 SEDA + AREA PERINEAL BILATERAL+ AREA PERIANAL+ AREA
INTERGLUTEA**Profesional:** LUIS GUILLERMO CANO ARIAS**Especialidad:** GINECOLOGIA ONCOLOGICA**Tarjeta Profesional #** 12126929

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT: 891180268-0

INFORME QUIRURGICO

Ingreso: 1951245

Página 1/3

Número de Folio: 110

Ubicación: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO E.S.E. - QUIROFANOS

IDENTIFICACIÓN

Apellidos: SAMORA SAMORA

Nombres: EMILCEN

Dirección: VEREDA PALESTINA SIN NOMENCLATURA - PITALITO - PITALITO

Teléfono: - 3173746960

Profesión: NO SE TIENE ESTA INFORMACION

Entidad Responsable: NUEVA EPS

Seguridad Social: NUEVA EPS

Tipo Documento: CC Numero: 1193257525

Edad: 46 Años 10 Meses 04 Dias (24/05/1978)

Sexo: FEMENINO

Tipo Paciente: SUBSIDIADO

Tipo Afiliado: NO APLICA

Estado Civil: SOLTERA

Grupo Étnico: NINGUNO DE LOS ANTERIORES

EQUIPO QUIRURGICO

Profesional	Perfil	Principal
LUIS GUILLERMO CANO ARIAS	Cirujano	☒
WILLIAM DIAZ HERRERA	Anestesiologo	☐
CATALINA SILVA ESQUIVEL	Instrumentador	☐
YENNY CATERINE LUCUARA ORTIZ	Circulante	☐
CLERY FERNANDA CISNEROS PEREZ	RESIDENTE II	☐
MELYSSA DIAZ BOHORQUEZ	INTERNA	☐

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Diagnósticos PRE-Operatorios:

CIE10	Diagnostico	Observaciones	Principal
D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO		☒
R520	DOLOR AGUDO		☐

Diagnósticos POS-Operatorios:

D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	☒
R520	DOLOR AGUDO	☐

INTERVENCION PRACTICADA/TIPO DE ANESTESIA Y DE HERIDA

Fecha Hora de Inicio: 28/03/2025 9:15:00 a. m.

Fecha Hora que Termina: 28/03/2025 11:47:00 a. m.

Cirugia urgente: ☐

Tiempo Quirúrgico(Minutos): 152

No Sala de Cirugía: 4

Profilaxis con

Tipo de Herida : Contaminada

Tipo de Anestesia : Combinada

Antimicrobianos: ☒

Clasificación ASA: 3

Datos Adicionales: Prótesis / Implante ☐ CX Caderas ☐ CX Rodillas ☐ Laparotomia ☐ Fractura Abierta ☐ Clas. Fractura:

Cirugías: (Can: Cantidad, P: Cirugía Principal)

Cod. C.U.P.S	Cirugía	Via Abordaje	Can. P.
652301	RESECCION DE TUMOR DE OVARIO POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☒
684103	HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL AMPLIADA POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☐
669201	SALPINGO-OOFORECTOMIA BILATERAL POR LAPAROTOMIA	UNICA VIA	1 ☐
544104	OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
471102	APENDICECTOMIA VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
590201	URETEROLISIS CON LIBERACIÓN O REPOSICIONAMIENTO DE URÉTER	UNICA VIA	1 ☐
545001	LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐
541703	LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO VIA ABIERTA	UNICA VIA	1 ☐

DESCRIPCION QUIRURGICA

Hallazgo Operatorio:

SINDROME ADHERENCIAL PELVICO Y ABDOMINAL SEVERO DE ASAS DELGADAS A PARED ABDOMINAL PRESENTANDOSE DURANTE SU LIBERACIÓN SOLUCION DE CONTINUIDAD EN YEYUNO DE 8CM QUE REQUIRIO LA RESECCION INTETINAL MAS

ANASTOMOSIS LATEROLATERAL CON SUTURA MECÁNICA POR CIRUGIA GENERAL (DR NEFTALI VARGAS. MÚLTIPLES ADHERENCIAS INTERASAS DELGADAS, DEL ILEON , A YEYUNO, Y A PARED ABDOMINAL FIJAS QUE SE LIBERAN EN FORMA DISPENDIOSA PRESENTANDOSE LACERACIÓN DE LA SEROSA EN YEYUNO ILEON QUE SE SUTURA CON SEDA 3-0 SIN COMPLICACIONES. UTERO NORMAL, ANEXO DERECHO ATROFICO. ANEXO IZQUIERDO CON MASA TUMORAL OVARICA LOBULADA DE 18X16CN DE CAPSULA GRUESA CON GRAN PROCESO ADHERENCIAL INFLAMATORIO Y CON ADHERENCIAS MÚLTIPLES AL YEYUNO, ILEON, URETERES LOS CUALES DEFORMA EN S TRAYECTO. EPIPLON ADHERIDO AL BORDE SUPERIOR DE LA MASA QUE SE RESECA CON LIGAURE, HIGADO, BAZO, ESTÓGO, ASAS INTESTINALES DELGADAS Y GRUESAS NORMALES. GOTERAS PARIETOCÓLIAS Y CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS LIBRES. GANGLIOS PELVICOS Y PARAORTICOS NORMALES. PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES. SANGRADO 600CC. ORINA CLARA AL FINALIAR. CONTEO Y RECONTEO DE COMPRESAS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGOC COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

DX BIOPSIA POR CONGELACIÓN: DRA RINA LUNA PATOLOGA
TUMOR OVARIO IZQUIERDO: TERATOMA MADURO ABSCEDADO

Detalle Quirúrgico - Procedimientos:

BAJO ANESTESIA GENERAL, PREVIA SEPSIA DEL CAMPO OPERATORIO Y CATETERISMO VESICAL Y UTILIZACION DE PROTOCOLOS INSTITUCIONALES PARA COVID-19 , SE REALIZA INCISION MEDIANA INFRA Y SUPRAUMBILICAL, SE RETIRA CICATRIZ MEDIANA PREVIA, SE INCIDE POR PLANOS HASTA CAVIDAD, SE IDENTIFICAN ESTRUCTURAS PELVICAS Y ABDOMINALES CON LOS HALLAZGOS DESCRITOS. SE REALIZA LAVADO PELVICO, SE PROCEDE A REVISAR LIBERACION DE TODAS LAS ADHERENCIAS DE LA MASA TUMORAL OVARICA IZQUIERDA AL YEYUNO, ILEON, PERITONEO DEL FONDO DE SACO, SEROSA DEL RECTO Y URETERES LOS CUALES SE LIBERAN REPOSICIONANDOLOS A SU TRAYECTO NORMAL, SE LIBERAN MÚLTIPLES ADHERENCIAS INTERASAS DEL ILEON AL YEYUNO Y DEL ILEON AL CIEGO, DEL APENDICE AL PERITONEO DE LA FOSA ILIACA DERECHA, ADHERENCIAS DEL EPIPLON AL PERITONEO PARIETAL UMBILICAL Y DEL EPIPLON AL BORDE SUPERIOR DE LA MASA TUMORAL. SE ABRE HOJA POSTERIOR DEL PERITONEO , SE IDENTIFICAN VASOS PELVICOS Y URETERES , SE ABRE FOSA PARAVESICAL Y PARARECTAL , SE PINZAN CORTAN Y LIGAN CON LIGASURE LIGAMENTOS INFUNDIBULOPELVICOS Y LIGAMENTOS REDONDOS, SE ABRE HOJA ANTERIOR DEL PERITONEO Y SE RECHAZA LA VEJIGA Y EN CARA POSTERIOR EL RECTO. SE PINZAN CORTAN Y LIGAN VASOS UTERINOS CON LIGASURE , SE PINZAN CORTAN Y LIGAN LIGAMENTOS UTEROSACROS Y PARAMETRIOS CON LIGASURE, SE PINZAN ANGULOS DE LA CUPULA VAGINAL CON VICRYL 1-0 Y SE RESECA MANGO VAGINAL DE 1 CM COMPLEMENTANDOSE LA ECTOMIA, SE REALIZA JARETA CON CATGUT CROMADO 0 , SE REvisa HEMOSTASIA, SE REALIZA OMENTECTOMIA PARCIAL CON LIGASURE SIN COMPLICACIONES. SE REALIZA APENDICECTOMIA LIGANDOSE EL MESOAPENDICE CON LIGASURE Y LUEGO LA BASE DOBLEMENTE CON SEDA 2-0 Y SE REALIZA JARETA INVAGINANDO EL MUÑON CON VICRYL GASTROINTESTINAL 2-0. SE REALIZA LAVADO DE CAVIDAD PERITONEAL CON 600 CC DE SOLUCION SALINA HASTA OBTENER LIQUIDO CLARO , SE TOMAN MUESTRAS, SE RETIRAN COMPRESAS Y SE REVISAN EXHAUSTIVAMENTE LA CAVIDAD DESCARTANDO LA PRESENCIA DE CUERPO EXTRAÑO, Y SE ORDENA A LA INSTRUMENTADORA RESPONSABLE EL CONTEO Y RECONTEO DE COMPRESAS E INSTRUMENTAL QUIRURGICO EL CUAL ES INFOMADO COMO COMPLETO POR LO QUE SE CIERRA POR PLANOS HASTA PIEL.

Complicaciones:

NINGUNA

Materiales (Que se Deben Cobrar Adicional a la Tarifa de los Qx):

LIGASURE

Compresas: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Gasas: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Conteo Material: COMPLETO POR INSTRUMENTADORA RESPONSABLE.

Tejidos Enviados a Anatomia Patologica:

Número de Muestras: 6

- 1-UTERO Y ANEXO DERECHO (TROMPA Y OVARIO)
- 2-ANEXO IZQUIERDO TUMORAL (TROMPA Y OVARIO)
- 3- EPIPLON.
- 4-APENDICE
- 5-FRAGMENTO DE YEYUNO
- 6-LAVADO PELVICO

RECOMENDACIONES

NADA VIA ORAL
LACTATO DE RINGER A 100 ML /HORA
ANALGESIA POR ANESTESIOLOGIA
PIPERACILINA/ TAZOBACTAM IV 4.5 GR/6 HORAS DIA 0
AMIKACINA IV 1 GR CADA 24 HORAS DIA 0
METOCLOPRAMIDA 10 MG CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL IV 40 MG CADA DIA
ENOXAPARINA SUBCUTANEO 40 MG/24 HORAS (INCIAR EN 12 HORAS)
TERAPIA RESPIRATORIA CON INCENTIVO RESPIRATORIO 2 VECES AL DIA
TERAPIA FISICA INTEGRAL (2 VECES AL DIA)
-SONDA VESICAL A CISTOFLO
-CONTROL DE SIGNOS VITALES Y TEMPERATURA CADA 4 HORAS
-RESTO DE ORDENES POR UCI

-RESTO DE ORDENES POR CIRUGIA GENERAL



Profesional: LUIS GUILLERMO CANO ARIAS

Especialidad: GINECOLOGIA ONCOLOGICA

Tarjeta Profesional # 12126929